

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'
רפואת המשפחה

28.05.24

מס' השאלות בחלק זה: 100

יש לענות את התשובה הנכונה והמלאה ביותר

1. כאשר ישנו חשד לאלימות זוגית מה נדרש מהרופא לעשות?
 - א. הערכת מסוכנות, דיווח למשטרה במידה וקיימת אלימות.
 - ב. הערכת מסוכנות, יידוע על מסגרות לקבלת עזרה בקהילה, במידה ויש קטינים הערכה האם נמצאים בסיכון.
 - ג. הפניה לעובדת סוציאלית ודיווח לפקידת סעד.
 - ד. זימון שני בני הזוג, דיווח למשטרה במידה וקיימת אלימות.
2. בן 79, התאלמן לפני כשנה. BMI נוכחי 21. איבד כ 5% ממשקלו בשנה החולפת. בירור מעבדתי והדמייתי ללא ממצאים מכוונים, ציון PHQ9 10. מה הטיפול המתאים ביותר?
 - א. תוספת של 2 בקבוקי אנשור ביום.
 - ב. תוספת טיפול במולטי ויטמינים.
 - ג. Mirtazapine (Miro)
 - ד. Fluoxetine (Prozac)
3. מהו הטיפול התרופתי שדורש התאמת מינון למטופל עם $GFR 40 \text{ ml/min/1.73 m}^2$?
 - א. Januet (Metformin+Sitagliptin)
 - ב. Forxiga (Dapagliflozin)
 - ג. Trajenta (Linagliptin)
 - ד. Ozempic (Semaglutide)
4. בן 35 התעורר בבוקר עם כאב עז בגב. בצילום שבר דחיסה בשתי חוליות. בדיקת צפיפות עצם מראה ערכי T score בפרק הירך (2.7-) ובעמוד שדרה (2.9-). איזו בדיקה מרמזת על גורם למצבו?
 - א. $PTH = 8 \text{ pg/mL}$ (normal 10-60 pg/mL).
 - ב. $TSH 12 \text{ mIU/L}$ (normal 0.5-4 mIU/L).
 - ג. Dexamethazone suppression test חיובי.
 - ד. Total Testosterone 1200 ng/dL (normal 270-1080 ng/dL).

5. בן 56, ברקע - עודף משקל (BMI 29) ומצב טרום סוכרתי. בעברו התקף אחד של גאווט. ללא נחירות או ישנוניות יומית. ממוצע של מדידות לחץ הדם במדידות ביתיות הוא 160/100. במעבדה $95 \text{ GFR } 1.73 \text{ m}^2/\text{min}/\text{ml}$, אשלגן 4.1 מג%, נתרן 139 מג%. הוא אינו נוטל טיפול תרופתי. מהו הטיפול המתאים ביותר עבורו לאיזון לחץ הדם?
- א. Exforge (Valsartan + Amlodipine)
ב. Tritace Comb (Ramipril + Disothiazide)
ג. שינוי אורח החיים לפני החלטה על טיפול תרופתי.
ד. Amlodipine (Amlow)
6. בן BMI-35,38 ללא מחלות רקע. מתלונן על צרבת שמחמירה בשעות הערב ובשכיבה, וצרידות. ניתנה המלצה לשינוי אורחות חיים (תזונה וירידה במשקל) עם ניסיון טיפולי ב-Nexium (Esomeprazole) במינון 20 מג ליום, עם השפעה חלקית בלבד. מהי ההמלצה המתאימה ביותר כעת?
- א. להפנות את המטופל לגסטרוסקופיה
ב. להחליף ל- Controloc (Pantoprazole)
ג. להחליף טיפול ל- Gastro (Famotidine)
ד. להשלים בדיקת נשיפה ל- Helicobacter Pylori
7. באילו מהמקרים הבאים יש לתת טיפול פרופילקטי למניעת אנדוקרדיטיס?
- א. מטופל עם מחלת לב ראומטית, לפני קולונוסקופיה.
ב. מטופל שהחלים מאנדוקרדיטיס לפני 10 שנים, לפני ניתוח החלפת ברך.
ג. מטופל שעבר ניתוח תיקון מום לב כחלוני לפני 11 חודשים, לפני טיפול שיננית.
ד. מטופל אחרי החלפת מסתם אאורטלי (TAVI), לפני ביופסיה בברונכוסקופיה.
8. מי מהבאים מבצע את בדיקות הסקר המומלצות עבורו בהתאם להנחיות?
- א. בן 18, אביו אובחן לאחרונה עם Lynch Syndrome וסרטן הרקטום בגיל 40, עתיד לבצע קולונוסקופיה השנה.
ב. בת 20, אמה אובחנה לאחרונה עם סרטן צוואר הרחם בגיל 50, תבצע בדיקת HPV Typing מגיל 25 אחת ל-3 שנים.
ג. בן 40, אביו אובחן לאחרונה עם סרטן ערמונית בגיל 60, מבצע בדיקת PSA ובדיקה רקטלית אחת לשנה.
ד. בת 35, נשאית BRCA2, אמה אובחנה עם סרטן שד בגיל 50, עוברת US נרתיקי ובדיקת CA-125 אחת לשנה.

9. בת 22, בריאה, רקדנית בלט מקצועית. מדווחת על חולשה והעדר ווסת מזה 8 חודשים. בבדיקתה: BMI 16, מדדים תקינים, שאר בדיקה גופנית ללא ממצאים חריגים. מעבדה: HCG שלילי, LH<10, FSH<10, אסטרוידיל נמוך, פרולקטין תקין, טסטוסטרון תקין, AMH (Anti Mullerian Hormone test) מוגבר, OH-Progesterone17 תקין. אילו מהבדיקות הבאות רלוונטיות לאבחנה הסבירה ביותר?
- א. US אדרנלים ושחלות.
- ב. MRI מח.
- ג. צפיפות עצם.
- ד. קריוטיפ.
10. בן 14 חלה בברוצלה (Brucellosis) אשר הוכח בסרולוגיה במעבדה לאחר שאכל גבינה שאינה מפוסטרת. מה חובת דיווח במקרה זה?
- א. לדווח מיידית למשרד הבריאות על ידי יצירת קשר טלפוני עם הלשכה המחוזית.
- ב. לדווח למשרד הבריאות על ידי שליחת טופס ייעודי ללשכה המחוזית.
- ג. לדווח למשרד הבריאות רק אם יש צבר תחלואה של מעל שני מקרים באיזור מגורים אחד.
- ד. לדווח למשרד הבריאות רק בהסכמת ההורים מכיוון שמדובר בקטין.
11. בת 45, ילידת הארץ, בריאה בד"כ, לא נוטלת תרופות קבועות, לא מעשנת. מזה למעלה מחודש ימים סובלת משיעול עם ליחה לבנה אך מדי פעם יש פסי דם בליחה. ללא תלונות נוספות. בדיקה גופנית תקינה. צילום חזה תקין. מהי הבדיקה הנדרשת בשלב זה להמשך הבירור?
- א. CT חזה.
- ב. ברונקוסקופיה.
- ג. כיח לתרבות.
- ד. צילום חזה חוזר בעוד 3 חודשים.
12. בת 56 מתלוננת על שריפה בחלק הלטראלי העליון של ירך ימין. הכאב החל לפני מספר חודשים, מחמיר בהליכה ומוקל בשכיבה ובישיבה. מהם הממצאים בבדיקה גופנית בהתייחס לאבחנה הסבירה ביותר?
- א. רגישות במישוש שרירים Paravertebral.
- ב. חולשת שרירי Iliopsoas ו-Qudariceps.
- ג. היפר-רפלקסיה בגפה ימנית תחתונה.
- ד. השמנת יתר: BMI= 35

13. בן 35 ברקע - דיכאון, מעוניין בטיפול תרופתי אך מבקש חומר שהכי פחות פוגע בחשק המיני. מה מבין התרופות הבאות הכי מתאימה למקרה זה ?

- א. Lustral (Sertraline)
- ב. Viepax (Venlafaxine)
- ג. Favoxil (Fluvoxamine)
- ד. Seroxat (Paroxetine)

14. בן 60, ברקע - יתר לחץ דם לא מאוזן. לאחרונה קוצר נשימה במאמץ, אקו לב: LVEF=45%. מטופל ב. 2.5 mg -Tritace (Ramipril)
מדידות לחצי דם בבית – סביב 150/90 מ"מ כספית, דופק ממוצע 75 לדקה .
בבדיקה גופנית ללא בצקות פריפריות, ללא קרפיטציות בהאזנה לריאות .
מהו הטיפול שיש להוסיף ?

- א. Cardiloc (Bisoprolol), Aldospirone (Spironolactone)
- ב. Norvasc (Amlodipine), Cardiloc (Bisoprolol)
- ג. Fusid (Furosemide), Cardiloc (Bisoprolol), Aldospirone (Spironolactone)
- ד. Digoxin, Aldospirone (Spironolactone)

15. בת 35, מתייצגת עם תפרחת דיסקואידית, תרומבוציטוזיס קל, כאבי מפרקים בכפות ידיים ובברכיים, מלווים בנוקשות בוקר למשך 40 דקות ותופעת ריינו באצבעות 2-3 ביד ימין .

מהו השלב הבא בבירור על מנת לאשש את האבחנה הסבירה ביותר?

- א. אין צורך בהמשך בירור, ניתן לאבחן את מחלתה על בסיס הנתונים הקיימים .
- ב. יש להשלים בדיקת ANA.
- ג. יש להשלים בדיקת anti-dsDNA.
- ד. יש להשלים בדיקת ESR.

16. בן 30, מלין על כאבים בחלק מדיאלי של המרפק מזה כחודשיים. בבדיקתו: ללא כאב באקסטנציה של המרפק (כאשר האמה בסופינציה וושוורש כף היד בדורסיפלקסיה), ירידה בתחושה באצבע 5 ואטרופיה של שריר ה-1. *dorsal interossei*. מהו הטיפול המתאים למקרה זה?
א. Splint ללילה.
ב. קורס של NSAID למשך 14 ימים.
ג. הזרקת סטרואידים ל *medial epicondyle*.
ד. ניתוח.
17. בן 55, פוטר מעבודתו. מתאר מצב רוח ירוד, קשיי שינה וירידה בתאבון. מה יתמוך באבחנה של הפרעת הסתגלות (Adjustment disorder)?
א. הפיטורין התרחשו לפני 7 חודשים.
ב. איטיות פסיכומטורית וירידה באנרגיה.
ג. המטופל עדיין נהנה לראות משחקי כדורגל.
ד. לפני מספר שנים טופל בתרופות מייצבות מצב רוח.
18. בן 75, ברקע - סוכרת ללא פגיעה באברי מטרה. מזה שלושה ימים חום 39 וכאבים באוזן. בבדיקה – אודם ובצקת של התעלה והאפרכסת, הפרשה מוגלתית מהאוזן, אודם בולט ורגיש באזור מסביב לאוזן והשטחה של קמט נזולביאלי באותו צד. מהו הטיפול המומלץ ביותר?
א. טיפול אנטיביוטי תוך ורידי מיידי במסגרת אשפוז בבית חולים.
ב. טיפול מקומי בטיפות (Ciprofloxacin) Ciloxan-בשילוב סטרואידים ססטמיים.
ג. טיפול פומי ב Zovirax (Acyclovir)-בשילוב עם Prednisone פומי.
ד. טיפול פומי ב Augmentin (Amoxycillin Clavulanate)-ושטיפות מי חמצן לתעלה.
19. בן 40, פונה עקב תפרחת שלא נעלמת בלחיצה. באיזה מקרה יש לשלוח בדיקת דם ל Antinuclear Antibody ול Rheumatoid factor?
א. נגעי ecchymoses קטנים 6 ס"מ, ממוקמים בשוקיים.
ב. נגעי purpura נמושים (מורמים מעט).
ג. תפרחת מלווה בחום גבוה ואוושה לבבית.
ד. התפרחת הופיעה לאחר כמה ימי טיפול ב Ibuprofen-לכאבי גב.

20. למי מהבאים מומלץ טיפול תרופתי ב Bupropion (Zyban)-לגמילה מעישון?

א. בן 65, אובחן לאחרונה עם פרקינסון, מטופל ב. Azilect (Rasagiline)

ב. בת 40, ברקע - עודף משקל, סובלת מדכאון ומבולימיה

ג. בן 52, חודש לאחר צנתור לבבי, סובל מ. Erectile Dysfunction

ד. בת 16, ברקע - השמנת יתר חולנית. (BMI 41)

21. לפניך תיאור של מטופלים בני 50 המתלוננים על כאבי גב תחתון.

מי מהבאים יופנה לבירור הדמייתי דחוף ?

א. כאב מקרין לרגל שמאל שהחל אתמול לאחר הרמת הנכד, מתגבר בשינוי תנוחה. בבדיקה - מבחן SLR חיובי משמאל .

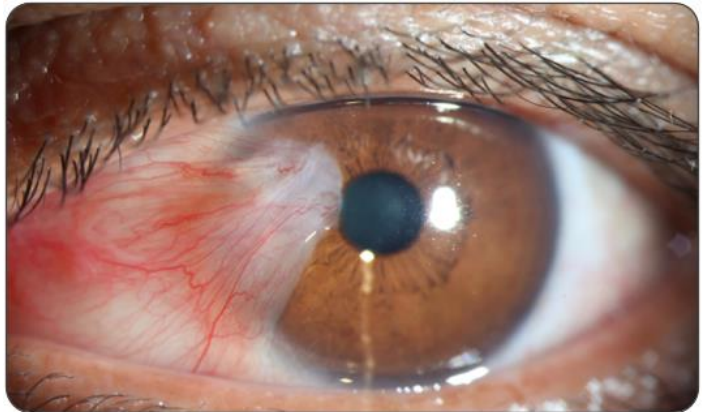
ב. כאב מלווה בחום וצמרמורות שהחל לפני שבוע, לאחר שעבר ניקוז מורסה בחניכיים, בבדיקה - ללא ממצא חריג.

ג. כאב מקרין לרגל ימין, מלווה בנימול בחלק האחורי של הירך. החל לפני מספר ימים והתגבר היום, בבדיקה - ירידה בתחושה מהעכוז לירך ימין.

ד. כאב משמאל, הופיע לפני מספר ימים ללא טריגר ברור, בבדיקה – תפרחת שלפוחיתית.

22. בן 32 מציג שינויים הדרגתיים במראה העין במהלך השנה האחרונה. בדיקה גופנית מגלה ממצאים שנראו בתמונה.

מהי האבחנה הסבירה ביותר?



א. דלקת לחמית.

ב. גוף זר.

ג. Pinguecula.

ד. Pterygium.

23. בן 7, בריא ברקע, ללא רגישות ידועה לתרופות. לפני כחודש חלה בדלקת שקדים וטופל במוקסיפן (Amoxicillin) לפני כעשרה ימים החל צינן שקוף, מלווה בכאבי שרירים וכאב גרון קל שחלף. מזה כ- 5 ימים הופיעה נזלת מוגלתית, מלווה בחום 39 מעלות צלזיוס ולחץ על פני הפנים.

מהו הטיפול המומלץ ביותר למצבו?

א. Moxypen (Amoxicillin)

ב. Augmentin (Amoxicillin+Clavulanate)

ג. Azenil (Azythromycin)

ד. Tavanic (Levofloxacin)

24. בן 9, מחוסן כפי גילו. מאובחן ומקבל טיפול בסטרואידים עקב תסמונת נפרוטית. הגיע למרפאה כשעה לאחר נשיכת כלב לא מוכר. בבדיקתו: ערני וחיוני, פצע שטחי באמה, ללא סמיכות למפרקים. מהו הטיפול המומלץ בנוסף להפנייתו ללשכת הבריאות לשקילת חיסון לכלבת?

א. חיטוי המקום במים וסבון, מריחת משחת Polidine.

ב. טיפול אנטיביוטי ב. Augmentin (Amoxicillin+Clavulanate)

ג. חיטוי ומריחה מקומית במשחת Fucidin (Fucidic Acid)

ד. הטרייה של אזור הנשיכה.

25. בן 65, ברקע - COPD מזה 10 שנים. מטופל כעת במשאף (Fluticasone Trelegy (umeclidinium, vilanterol) furoate, umeclicidinium, vilanterol) שלוש החמרות של COPD ושני אשפוזים.

מהי ההתוויה להוספת טיפול ב Daliresp (Roflumilast)?

א. שיעול ליחתי כרוני, בספירומטריה 40% FEV1.

ב. לא מעשן מזה חמש שנים.

ג. סובל מקוצר נשימה במאמץ קל (mMRC3).

ד. אאוזינופילים בדם 400 תאים/מיקרוליטר.

26. בת 50, ברקע - השמנת יתר (BMI 31) מזה כשבועיים כאב דוקר בכף הרגל בחלק הפלנטרי אנטרו-מידאלית של העקב. הכאב חזק ביותר עם הקימה ומשתפר לאחר מספר צעדים.

מהו הטיפול המתאים ביותר למצבה בשלב זה?

א. מתיחות באמצעות פלנטר פלקציה של כף הרגל.

ב. מדרסי "מדף" (ללא התאמה אישית).

ג. הזרקת לידוקאין לאיזור הכאוב.

ד. ניתוח.

27. במי מהבאים יש להתחיל טיפול בתכשיר SSRI ?
- א. בת 19, שבוע 39 להריונה הראשון, ציון נמוך בשאלון Edinburgh, להמליץ על טיפול פרופילקטי לפני הלידה.
- ב. בת 26, שבוע לאחר לידה, מתקשה לישון, חשה אי שקט, ירידה משמעותית במצב רוחה ועצבנות.
- ג. בת 23, בעברה דכאון מג'ורי, חודש וחצי לאחר לידה. לא ישנה 3 ימים ברצף, בעלת קצב דיבור מהיר, עוברת במהירות מנושא לנושא במהלך השיחה .
- ד. בת 36, 7 שבועות אחרי לידה, שאלון Edinburgh ציון 10/13 .
28. מה מהווה קונטרא-אינדקציה מוחלטת להנקה?
- א. Hepatitis B פעיל באם .
- ב. Galactosemia בילוד.
- ג. אבצס בשד האם.
- ד. חייר שסוע (cleft palate) בילוד.
29. בן שנתיים וחודשיים, שאינו מוכר לרופא, הגיע עם הוריו, כאוב ובוכה. הוריו מספרים שחזר מהגן ומאז נמצא באי שקט. בבדיקה מסרב להזיז את זרוע ימין ומתחמק מהבדיקה .
- מהי ההתייחסות המתאימה ביותר ?
- א. בהדמיית זרוע ימין שבר חדש וכן שברים ישנים בגילאים שונים, נפנה למיון לצורך גיבוס ובמקביל נדווח לפקידת הסעד בעיר.
- ב. בבדיקה רגישות בראש הרדיוס, נבצע מניפולציה להחזרת המפרק, ובמקביל יש להתייעץ עם עובדת סוציאלית בסניף.
- ג. בהדמיית כף היד שבר ברדיוס הדיסטלי (BUCKLE FRACTURE) נפנה למיון לצורך גיבוס ובמקביל נדווח למשטרה.
- ד. בהדמיית הזרוע שבר ענף ירוק, נמליץ על שימוש במתלה למשך 10 ימים, ובמקביל נדווח לפקידת הסעד בעיר.

30. במחקר RCT נבדקו 3 תרופות מול פלצבו למניעת סיבוכי המחלה. על פי נתונים אלה מהו הטיפול היעיל ביותר ?

20% פתחו את סיבוך המחלה	פלצבו
NNT (Number Needed to Treat) = 10	תרופה א
RRR (Relative Risk Reduction) = 75%	תרופה ב
ARR (Absolute Risk Reduction) = 10%	תרופה ג

- א. תרופה א.
- ב. תרופה ב.
- ג. תרופה ג.
- ד. לשלושת הקבוצות שיעור זהה.

31. בת 86, חדשה בטיפולך. ברקע - דמנציה קלה, מתגוררת לבדה, מגיעה מטפלת 20 שעות שבועיות. לוקה בסוכרת סוג 2 מזה כ-10 שנים, מטופלת באינסולין 30 Toujeo (Glargine) יחידות, Metformin 850 mg פעם ביום, 5 mg Gluben (Glibenclamide) פעם ביום. BMI 25.

בבדיקות מעבדה האחרונות: גלוקוז 112 צום, רמת HBA1C 6.4% ערך $eGFR = 40$ מל/דקה, ללא מיקרואלבומינוריה.

מהי ההמלצה להמשך הטיפול התרופתי כעת ?

- א. הפסקת Metformin.
- ב. הפסקת Gluben (Glybenclamide).
- ג. אין צורך בשינוי תרופתי.
- ד. הוספת Forxiga (Dapagliflozin).

32. בן 65 מגיע מלווה בבנו. הבן מדווח שאבא מרגיש מסוחרר ומדבר לא לעניין מהבוקר . ברקע - יתר לחץ דם, מטופל ב Tritace (Ramipril) ו-Amlow (Amlodipine)-ולרוב מאוזן. לאחרונה עקב כאבי גב טופל ב Naxyn (Naproxen)-עד אתמול.

בבדיקתו - מזהה אותך אבל לא מדבר לעניין. מדידת ל"ד כעת ערכים של 200/110 מ"מ כספית.

בנתונים הקיימים מה הטיפול המומלץ בשלב זה?

א. Capoten (Captopril) 25 mg מתחת ללשון וביקורת למחרת.

ב. העלאת מינון Amlow (Amlodipine) כעת וביקורת למחרת.

ג. העלאת מינון Tritace (Ramipril) כעת במרפאה והוספת Amlow (Amlodipine) בבית וביקורת למחרת.

ד. מתן Labetalol בטיפול דרך הווריד (IV) במסגרת טיפול נמרץ.

33. בן 80, מגיע מלווה באשתו שמספרת כי לאחרונה הבחינה שכן זוגה שוכח דברים רבים כגון את שמות ילדיהם, שמות חפצים ואפילו שכח את הדרך לביתם לאחר ביקור אצל חבר אותו נוהג לבקר לעיתים קרובות. אשתו חוששת כי בעלה מפתח אלצהיימר .

מה מהווה קריטריון אבחנתי ?

א. האבחנה מתבססת בעיקרה על בדיקה גופנית ומבחן MMSE.

ב. דרושה פגיעה בלפחות שלושה תחומים קוגניטיביים .

ג. מהלך המחלה מאופיין בהחמרה אקוטית ומהירה.

ד. להשלים בדיקת MRI אשר תדגים אטרופיה מוחית .

34. בת 23, ביעוץ טלפוני מבקשת טיפול אנטיביוטי עקב דחיפות, צריבה ושריפה במתן השתן. ללא חום גוף מוגבר. באיזה מצב ניתן לרשום אנטיביוטיקה ללא ביקור במרפאה?

א. יחסי מין לא מוגנים לאחרונה.

ב. דלקת בדרכי השתן לפני 8 שבועות.

ג. קושי במתן השתן.

ד. טיפול ב Imuran-למחלת קרוהן.

35. בת 70 מלינה על כאבים שורפים מלווים ברדימות בקדמת כף הרגל באזור ה Metatarsus- האמצעיים. הכאבים מחמירים בשימוש בנעליים סגורות .

בבדיקתה: לחץ על צידי ה Metatarsus-גורם להפקת הכאב, סימן על שם Mulder חיובי. מהי האבחנה הסבירה ביותר ?

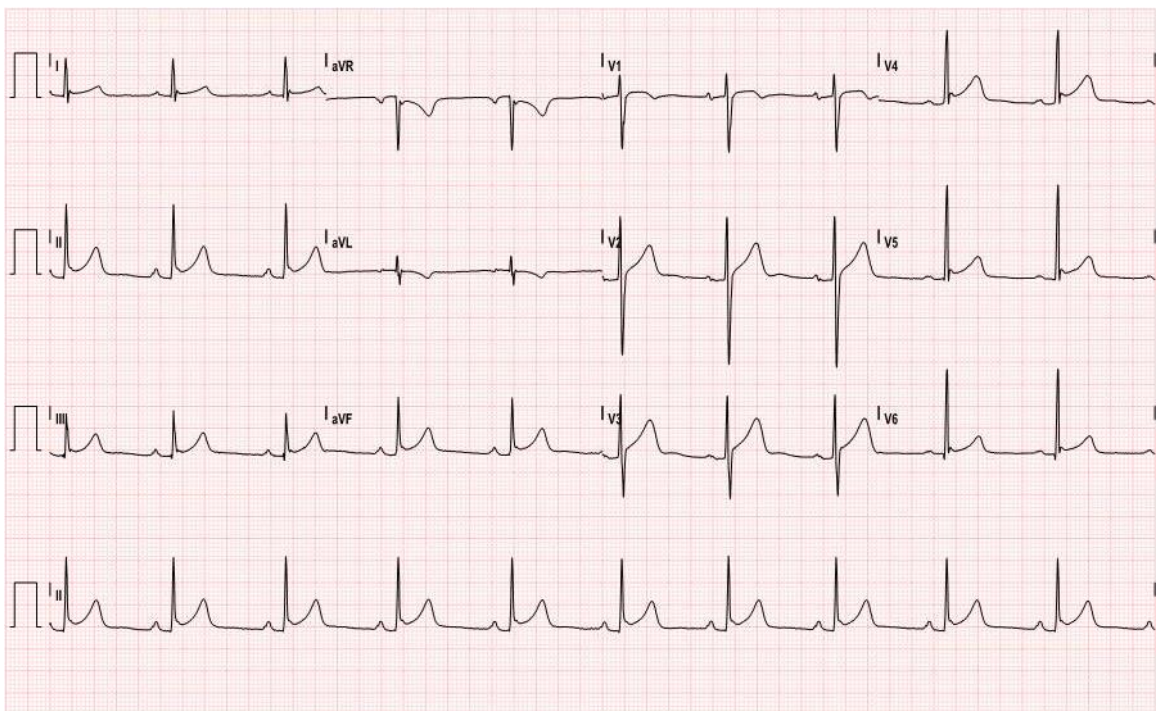
א. Posterior tibial nerve compression.

ב. Lateral plantar nerve entrapment.

ג. Sesamoid disorder.

ד. Morton's neuroma.

36. בת 52, פונה בשל כאב בחזה. באק"ג במרפאה:



מה מהבאים באנמנזה מתאים לאבחנה הסבירה ביותר?

א. הופעת הכאב בצורה חדה- תוך מספר דקות.

ב. הכאב מתואר כלוחץ ומחמיר במאמץ גופני.

ג. בנוסף לכאב בחזה ישנה גם נפיחות ורגישות באחת השוקיים.

ד. אבחנת רקע של זאבת. (SLE=Systemic Lupus Erythematosus)

37. בת 60, ברקע - BMI 42, Creatinine Clearance – 50 mL/min, לאחר ניתוח כריתת כיס מרה. התפתח DVT בווריד Deep Femoral vein בגפה ימנית תחתונה .

מהו טיפול הבחירה אצל מטופלת זו ?

א. Warfarin (Coumadin) בחפיפה עם Enoxaparin (Clexane).

ב. Apixaban (Eliquis)

ג. Dabigatran (Pradaxa)

ד. Inferior vena cava filter.

38. בת 70, ברקע סוכרת ועודף שומנים בדם, מגיעה עם בנה למרפאה. מתלוננת ששוכחת שמות, והיכן הניחה חפצים. הבן מתאר שחוזרת על אותם דברים שוב ושוב ושנוטה להתבלבל במקומות לא מוכרים .

מה כולל הבירור הראשוני במצבה?

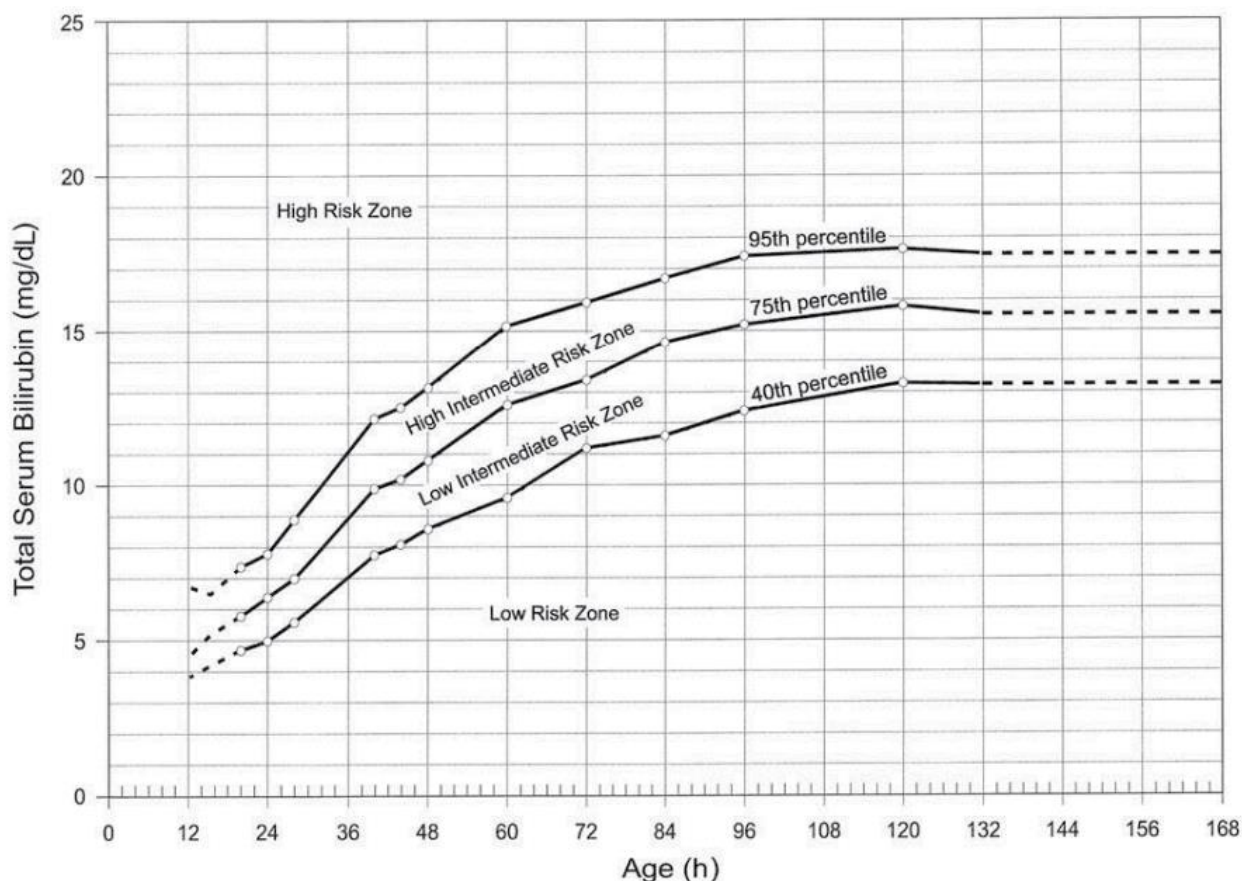
א. דופלר עורקי צוואר.

ב. שאלון PHQ2 (Patient Health Questionnaires).

ג. אקו לב.

ד. רמת ויטמין D.

39. תינוקת בת 5 ימים, נולדה בשבוע 38+5, לידה וגינלית במהלך תקין, במשקל 3300 גרם, שוחררה אחרי יומיים מבית החולים ללא צהבת עורית, ניזונה מהנקה בלעדית. כעת בבדיקה רושם לצהבת בלחמיות וצהבת עורית. בוצעה בדיקת דם לבילירובין. בבדיקת הדם ערך של בילירובין כולל של 16 מ"ג/ד"ל, מצורפת עקומת בוטאני.



מה הצעד הבא לבירור וטיפול?

א. לחזור על בדיקת בילירובין בגיל שבוע, ולהמליץ על מתן תזונה מבוססת תמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות).

ב. חזרה על בדיקת בילירובין אחרי 48 שעות וחשיפה לשמש כשעה ביום.

ג. בדיקת בילירובין בשתן מרמזת על צהבת פזיולוגית ויש לבצע מעקב בלבד.

ד. לחזור על בדיקת בילירובין כעבור 24 שעות ולהשלים בירור מעבדתי לצהבת.

40. באיזה מהמקרים הבאים של בצקות ברגליים יש מקום להפנות לבצוע בדיקת D-DIMER?
- א. בן 78, ברקע - יתר לחץ דם, בצקות דו צדדיות ברגליים מזה שבועיים, בבדיקה - הרחבת ורידי צוואר.
- ב. בן 62, בצקת ברגל ימין מזה כחצי שנה, בחודש האחרון גם ברגל שמאל. בבדיקה - דליות.
- ג. בת 55, מאתמול בצקת ניכרת בשוק ימין. ב US-ברך ימין שעשתה לפני חודש נראתה ציסטה על שם בייקר.
- ד. בת 57, מזה 3 ימים בצקת ניכרת ברגל שמאל לכל אורכה, בעברה אירוע של DVT.

41. בן שנה וחצי מובא למרפאה עם יומיים חום 39-40 מעלות צלזיוס, אי שקט, קושי לאכול ולשתות, ריור. בבדיקה - מספר פצעים בפה, בשפתיים וסביב השפתיים. ללא פצעים אחרים בגוף.



- מה האבחנה הכי מתאימה בילד זה ?
- א. Aphthous stomatitis.
- ב. Impetigo.
- ג. Hand foot and mouth disease.
- ד. Herpes gingiva stomatitis.
42. מה מהבאים מהווה גורם סיכון להתפתחות שחמת הכבד בחולה עם Alcoholic liver disease ?
- א. מין נקבה.
- ב. שתיית מנת אלכוהול פעם בשבוע.
- ג. דלקת כבד. Hepatitis B.
- ד. שימוש לאחרונה ב-NSAIDs.

43. בן 45, מעשן קופסא וחצי ליום מגיל 20, ללא מחלות רקע וללא תלונות . מהי ההמלצה המתאימה ביותר לגבי בדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן ריאות?
א. להפנותו לבצוע צילום חזה פעם בשנה.

ב. לבצע בדיקת CT חזה בקרינה נמוכה פעם בשנה.

ג. לשלוח כיח לציטולוגיה ובדיקת רופא ריאות אחת לשנה.

ד. בגילו עדיין אין צורך בהתערבות לגילוי מוקדם.

44. בן 18, ללא מחלות רקע, ללא טיפול תרופתי. מלין על כאבים בשוקיים בזמן פעילות גופנית, לאחר כחמש דקות פעילות כל פעם. בבדיקתו: BMI 24, לחץ הדם ביד שמאל 150/90, ביד ימין 148/91, דופק 66 לדקה, סדיר, ריאות נקיות, קולות לב סדירים, אוושה סיסטולית, אין רגישות על הסובכים ואין ממצא עורי. בדיקת מפרקי הגפיים התחתונות תקינה. בבדיקת דפקים היקפיים לא נימושו דפקים בכפות הרגליים, והדפקים הפמורליים נימושו חלשים .

מהי בדיקת העזר שיש לבצע כעת כדי לאבחן את הסיבה ליתר לחץ הדם?

א. אקו לב.

ב. אק"ג.

ג. בדיקת דם לתפקודי כליות, סוכר בצום וליפידים .

ד. דופלר עורקי רגליים.

45. בקשיש סיעודי מרותק למיטה הופיע הממצא המתואר בתמונה. ללא חום, כאבים, או הפרשה . מה יכלול הטיפול?



א. פולידין וייבוש הפצע באוויר.

ב. הטריה כירורגית.

ג. חבישה רטובה כגון Hydrogel.

ד. אנטיביוטיקה פומית רחבת טווח.

46. בת 46, עד לפני שנה מחזורים סדירים, כעת מזה שנה ללא מחזור וסת .
מה נדרש לשם אבחון הפסקת המחזור החודשי (Menopause) באשה זו ?
א. אין צורך בבירור הורמונלי די בסיפור הקליני.

ב. רמה נמוכה של ערכי FSH.

ג. רמה מוגברת. AMH (Anti Mullerian Hormone).

ד. ערכים מוגברים של פרוגסטרון.

47. בת שבע וחצי שנים, לאחר חופשת הקיץ, כאשר התחילה את כיתה ג' החלה להתקשות להיפרד מהוריה בבוקר, מבטאת פחד "שמשהו רע יקרה להם", ומסרבת ללכת לישון בחדרה ללא נוכחות של אחד מהוריה בחדר .

מהו הטיפול המומלץ ביותר לילדה ?

א. הטיפול המומלץ במצבה הינו. Selective serotonin reuptake inhibitors.

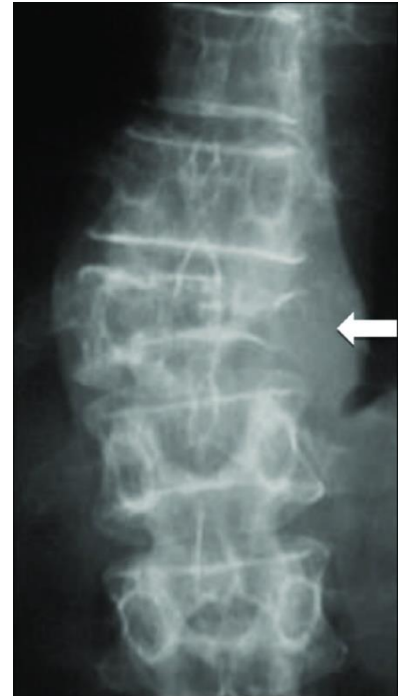
ב. המצב המתואר הינו חלק מההתפתחות התקינה ואינו דורש טיפול .

ג. הטיפול המומלץ במצבה הינו. Tricyclic antidepressants.

ד. הטיפול המומלץ במצבה הינו. Benzodiazepines.

48. בן 70 מתלונן על כאב גב חדש שהחל לפני מספר ימים, שולל נפילה/חבלה. מציין עייפות מזה כחודשיים. בבדיקה: ירד במשקל כ-5 ק"ג בחודשיים האחרונים, חיוורון. במעבדה – המוגלובין 10.2 גרם/ד"ל (לפני כשנה 14 גרם/ד"ל) וקריאטינין 1.8 מ"ג/ד"ל (לפני כשנה 1.0 מ"ג/ד"ל).

בצילום עמוד שדרה מתני (מצורף):



איזה ממצא מעבדתי יקדם את האבחנה?

- א. במח העצם בלאסטים מעל 10%.
- ב. יחס שרשראות קלות Kappa/Lambda 17 (טווח תקין 1.65-0.26).
- ג. רמת Parathyroid Hormone (PTH) – 27 פ"ג/מ"ל (טווח 14-65).
- ד. Hyperkalemia חדשה 5.8 מ"ג/ד"ל.

49. בן 22 מתלונן על כאב באזור הישבן ובגב התחתון. בבדיקה גופנית: הממצא המתואר בתמונה, רגישות ניכרת למגע עם פלוקטואציה.



מהו הטיפול המתאים?

- א. טיפול שמרני עם אמבטיות ישיבה.
- ב. טיפול ב (Mupirocin) Bactroban-מקומי.
- ג. טיפול פומי ב-Ceforal (Cephalexin).
- ד. ניקוז כירורגי בהקדם .

50. בקרב מטופלי תרופה חדשה לסוכרת שיעור ההיפוגליקמיה מסכנת חיים היה 1.8% לעומת 2 %

בקבוצת הביקורת. מה מהבאים נכון?

- א. Relative Risk Reduction 20%.
- ב. Absolute Risk Reduction 0.2%.
- ג. Relative Risk 0.8.
- ד. NNH=50.

51. בת 15, ידוע על השמנת יתר אצלה ואצל האם. לפני כשנה הומלצה פעילות גופנית וייעוץ תזונתי. כעת הנערה מספרת בגאווה שהיא שוחה בבריכה במשך שעה וחצי מדי יום ואוכלת הרבה פחות ממה שאכלה קודם. היא מציינת שיותר מקובלת חברתית. האם מספרת שמצד אחד היא שמחה על השינוי, ומצד שני היא חוששת שאולי מדובר בשינוי גדול מדי.
- הנערה שוללת דפיקות לב או הזעת יתר. ללא עצירות או תחושת קור. קיים איחור של חודשיים בוסת. בבדיקה לפני שנה הגובה היה 158 ס"מ (אחוזון 35 % ומשקל 60 ק"ג (אחוזון 82), (%כעת הגובה הוא 159 ס"מ (אחוזון 33 % והמשקל הוא 53 ק"ג (אחוזון 54 %)
- מהי ההערכה המיידית הנדרשת?
- א. להדריך את הנערה ואמה לקבוע פגישת מעקב אצל הדיאטנית.
- ב. לעודד את הנערה להמשיך ולבצע פעילות גופנית בינונית-עצימה במשך 60 דקות ביום (במקום 75 דקות) ולקבוע פגישת מעקב בעוד כחודשיים .
- ג. לשאול את המטופלת על הרגלי האכילה שלה ועל דימוי הגוף שלה .
- ד. לבצע בדיקת דם לתפקודי תריס .

52. בן 15 מתלונן על כאבי גב מזה כשלושה שבועות, מחמירים אחרי פעילות ומשתפרים במנוחה. הכאבים באמצע הגב .

בבדיקה – במבט מהצד חלקו העליון של עמוד השדרה מתעקל יותר מהרגיל עם זווית חדה יחסית כשהוא מתכופף .

בצילום עמוד שדרה צדדי בעמידה: חיתוך קדמי של 5 מעלות בשלושה גופי חוליות חזה סמוכים. (תמונה מצורפת) .



מהי האבחנה הסבירה ביותר?

- א. Discitis.
- ב. Scheuermann Kyphosis.
- ג. Scoliosis.
- ד. Spondylolysis.

53. בת 65, ברקע - יתר לחץ דם, סוכרת והיפרליפידמיה. מזה תקופה ממושכת מתלוננת על טשטוש ראייה וקשיי נהיגה בלילה. היא מסתנוורת לעיתים קרובות בזמן נהיגה בלילה. ללא טראומה או אובדן ראייה.

בדיקת העיניים מראה התכוות דו-צדדית של הרפלקס האדום, יחד עם עכירות .

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

- א. גלאוקומה סגורת זווית.
- ב. קטרקט.
- ג. גלאוקומה פתוחת זווית.
- ד. ניוון רשתית (AMD).

54. בת 29, בריאה, מגיעה בתלונה של גוש נמוש בשד שמאל. בבדיקה - ממצא בקוטר כ-2 ס"מ, מקובע, בעל מרקם הטרוגני. הושלמה בדיקת סונאר - הממצא בקטגוריה BIRADS-2. מהו הצעד האבחנתי הבא?

א. סונאר חוזר עוד חצי שנה.

ב. בדיקת FNA.

ג. בדיקת MRI שד.

ד. בדיקת ממוגרפיה.

55. בן 7 מובא למרפאה בשל תלונות על הקאות (אחת לחודש וחצי בחצי השנה האחרונה). בכל המקרים לא שלשל, לא סבל מחום גוף מוגבר. ללא דם גלוי בצואה. מציין כי לכל ההקאות קדמו בחילות ניכרות ולאחריהן כ-6 הקאות על פני כשעתיים ולאחריהן חזר לעצמו. מהי האבחנה הסבירה ביותר?

א. Cyclic vomiting.

ב. Eosinophilic esophagitis.

ג. Chronic intestinal pseudo-obstruction.

ד. Addison disease.

56. במי מהמקרים הבאים ניתן להסתפק במעקב בלבד, ללא צורך בבדיקות הדמיה או ביופסיה?

א. בן 22, לאחר נקע בקרסול, נמושה בלוטת למפה מאחורי הברך.

ב. בן 5, שבועיים לאחר מחלת חום ותפליטים על השקדים, נמושה בלוטה Supraclavicular.

ג. בן 35, שחקן טניס, נמושה בלוטה בקוטר 1 ס"מ, באזור Epitrochlear.

ד. בן שנתיים, מחלת חום חריפה, נמושו בלוטות למפה מוגדלות במפשעה ובצוואר וטחול מוגדל.

57. בן 65, סובל מרעד במנוחה. הרעד החל לפני כשנה, בעיקר באצבעות מימין אך לאחרונה החמיר ומערב את שתי הידיים. בבדיקתו הגופנית מופקת נוקשות. ללא הגבלה תפקודית. נסיון טיפולי ב L-Dopa (Levodopa) אישר את האבחנה.

מהו הטיפול המתאים ביותר כעת?

א. Rasagilune (Azilect).

ב. Ropinirole (Requip).

ג. Amantadine (PK Merz).

ד. Dopicar (Levodopa-Carbidopa).

58. בן 22 פנה למרפאה לאחר חבלה בעינו הימנית, לאחר שספג מכה ישירה תוך כדי משחק פיינטבול. מתלונן על כאבים בעין ימין וירידה בראייה. בדיקה גופנית מגלה דם בלשכה הקדמית עם פוטופוביה נלווית.

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

א. Episcleritis

ב. Hyphema

ג. Subconjunctival hemorrhage

ד. Vitreous hemorrhage

59. בן שנתיים, בריא, מובא למרפאה עקב חוסר מנוחה, אי מתן שתן, עור חם למגע מזה מספר שעות. ביום זה שהה אצל סבתו שמטופלת תרופתית.

בבדיקה – עור יבש וסמוק, לחץ דם 84/50 מ"מ כספית, דופק 172 לדקה, חום 37.9 מ.צ., אישונים

מורחבים וניע מופחת. אק"ג – טאכיקרדיה והרחבה של קומפלקס QRS.

בחשד להרעלה מה יכול להיות הגורם לתמונה הקלינית?

א. Percocet (Oxycontin + Paracetamol)

ב. Elatrol (Amitriptyline)

ג. Amaryl (Glimepiride)

ד. חומר להדברת חרקים המכיל זרחן אורגני.

60. בת 32, בהריון, נכוותה באמה השמאלית ממים רותחים. בבדיקתה במרפאה: כוויה בקוטר כ-3 ס"מ

עם מספר שלפוחיות קטנות.

מה הטיפול המיטבי כעת?

א. טיפול אנטיביוטי סיסטמי.

ב. ניקוז של השלפוחיות.

ג. תחבושת הידרוקולואידית.

ד. Silverol cream.

61. מי מהמטופלים הבאים עם אודם ברגליים יש להפנות למיון מיידית?

א. בן 34, אודם קל בשוק שמאל מלווה בצמרמורות, כאב בלתי נסבל וחום.

ב. בת 57, השמנה מורבידית, אודם בשוקיים דו"צ, ללא שינוי למרות טיפול ממושך באנטיביוטיקה.

ג. בן 25, לפני 3 שבועות נחתך ברגל, לאחר יומיים הופיע אודם סביב החתך, כעת אודם ניכר מערב את כל השוק.

ד. בת 70, אודם בהורדת הרגל, רגל קרה ולא מורגשים דפקים כלל.

62. בן 14, אובחן לאחרונה כסובל מ- Familial Mediterranean Fever (FMF) ההורים שואלים לגבי סיבוך בשם "עמילואידוזיס" שהזכיר הראומטולוג בפגישתם .
מבין הבאים מה תסביר להורים ?
- א. הסיבוך מסוכן ומתבטא בהתקפים חוזרים של כאבי בטן וחום .
ב. גורם סיכון להתפתחות הסיבוך הוא אי-דבקות בנטילת Colchicine.
ג. אבחון הסיבוך נעשה באמצעות בדיקת Serum Amyloid A (SAA).
ד. הביטויים השכיחים ביותר של הסיבוך הם macroglossia ונירופתיה .
63. בת 28, ללא ילדים, נשאת למוטציה ב BRCA2-שהתגלתה לאחר שאימה חלתה בסרטן שחלה בגיל 50.
מהו הטיפול המתאים ביותר להפחתת הסיכון לסרטן השחלה במטופלת זו?
- א. ניתוח לכריתת שחלות וחצוצרות עד גיל 50 .
ב. שימוש בגלולות משולבות, וניתוח לכריתת שחלות וחצוצרות עד גיל 40.
ג. הרחבת הבירור הגנטי לקביעת דרגת הסיכון לסרטן שחלה ובהתאם לתוצאה קביעת תזמון ניתוח לכריתת שחלות וחצוצרות.
ד. ניתוח לכריתת שחלות וחצוצרות כ-5 שנים לפני גיל האבחנה של האם.
64. המטופלים הבאים עברו ארוע של פקקת ורידים עמוקה (DVT) בודד.
למי מהבאים יש להשלים כעת בירור קרישתי ?
- א. בן 80, ברקע - עודף שומנים בדם, אירוע לפני שנה סביב ניתוח אורתופדי.
ב. בת 53, תת פעילות של בלוטת התריס, אירוע סביב טיסה טרנס-אטלנטית לפני ארבעה חודשים.
ג. בת 20, בריאה ברקע, אירוע לפני שבוע, ללא טריגר ידוע.
ד. בן 60, ברקע - סכרת, BMI 32, אירוע DVT ללא טריגר ברור לפני שנה.
65. בת 20, ספורטאית מקצועית והישגית מאד בתחום האתלטיקה. לאחרונה מתלוננת על שיעור יתר (גבות עבות יותר, וצורך תכוף להסרת שיער). מבין התרופות שהיא נוטלת, מה עלולה להיות הסיבה לכך ?
- א. גלולות Diane (Ethinylestradiol/Ciproteron Acetate) למניעת הריון.
ב. תוסף Andro (Androstendione) לבניית שרירים .
ג. Cipralex (Escitalopram) לשיפור OCD.
ד. תוספי ויטמינים B יחד עם C לחיזוק.

66. בת 67, ללא מחלות רקע וללא סיפור משפחתי של סרטן המעי הגס. ביצעה קולונוסקופיה כבדיקת סקר, הבדיקה תקינה.

על פי ההנחיות הקליניות מהי ההמלצה לגבי המשך בצוע בדיקת סקר לסרטן במעי הגס אצל מטופלת זו?

א. קולונוסקופיה חוזרת בעוד 5 שנים.

ב. בדיקה שנתי של דם סמוי בצואה החל מעוד 5 שנים.

ג. ניתן להפסיק בדיקות סקר לסרטן המעי הגס כעת.

ד. סיגמואידוסקופיה אחת ל-5 שנים.

67. בן 23 מתלונן שלא מצליח להרדם בלילה. נרדם בשעות מאוחרות מאוד ולכן מתעורר בבוקר בשעות מאוחרות, דבר שיצר בעיות במקום עבודתו כשליח. הוא לא מתעורר באמצע הלילה לאחר שנרדם, ולא חש ישנוניות במהלך היום. הוא חי עם הוריו, לא ידוע על מחלות רקע, אינו נוטל תרופות קבועות. מהו השלב הבא המתאים?

א. מתן Trazodil (Trazodone) במינון נמוך.

ב. מתן תכשיר Benzodiazepine במינון נמוך.

ג. מתן Circadin (Melatonin) לשלושה חודשים ומעקב.

ד. חינוך להגיגת שינה תקינה, תרגילי הרפיה ו Mindfulness.

68. בן 65 מתלונן על רעד בידים, שהחמיר לאחרונה ומפריע לו לתפקד. כששוחחה המים נשפכים מצידו הכוס. בבדיקה נוירולוגית מודגם הרעד, ללא רגידות, תפקודים צרבלריים תקינים.

איזה טיפול יומלץ למטופל זה?

א. Norvasc (Amlodipine)

ב. Prysoline (Primidone)

ג. L-Dopa (Levodopa)

ד. Azilect (Rasagiline)

69. בת 76, מזה זמן רב סובלת מדליפת שתן תוך דחף חזק להשתין. דליפת השתן מתרחשת עוד לפני ההגעה לשירותים. לאור התסמינים הוחלט על תחילת טיפול ב- Detrusitol (Tolterodine)

מה נכון לגבי הטיפול התרופתי במקרה זה?

א. מעלה סיכון להתפתחות הזיות.

ב. לא מהווה סיכון לישנוניות יתר.

ג. יכול לגרום להארכת מקטע PR.

ד. לא מושפע מתפקוד כלייתי ירוד.

70. לפי חוק החולה הנוטה למות מה מהבאים נכון ?

- א. הנחיות מקדימות תקפות מרגע החתימה ועד לחתימה על הנחיות חדשות.
- ב. חולה נוטה למות מוגדר כחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא ושתוחלת חייו אינה עולה על שלושה חודשים גם אם יינתן לו טיפול רפואי.
- ג. באם הרופא סבור כי טיפול מקובל ספציפי לא יזיק לחולה אך גם לא יאריך את חייו, הרופא רשאי לסרב למתן הטיפול גם באם החולה הנוטה למות מבקש זאת .
- ד. חולה בשלב סופי שלא הביע את רצונו לגבי פעולות מצילות חיים, רופא יכול לבחור שלא לבצע החייאה .

71. בן 75, סובל מיתר לחץ דם וסכרת מזה 20 שנים. מטופל ב Metformin 850 mg-פעם ביום. בחודש האחרון מתלונן על בחילות והקאות, ירד כ-6 ק"ג במשקלו, הופיעה ירידה בתפקוד הלב ($EF=40\%$) והחמרה בתפקוד הכלייתי ($eGFR=40$ מל/דקה). סוכר בצום 350 מ"ג/ד"ל .

מהו הטיפול המתאים ביותר במצבו כעת ?

- א. Forxiga (Dapagliflozin)
- ב. Insulin Glargine
- ג. עליה במינון Metformin.
- ד. Januvia (Sitagliptin)

72. בן 8 שנים, בריא, מדווח על ראייה כפולה מספר ימים. המצב לא מחמיר במשך היום, ולא נראית חבלה לעין. בבדיקתו סגירת כל עין בנפרד מעלימה את הכפל ראייה. מראה העיניים סימטרי, ללא פטוזיס. בלט עין ניכר, העפעף העליון מעט נפוח ומאחר בסגירה. בדיקה נוירולוגית תקינה .

מה האבחנה הסבירה ביותר ?

- א. Myasthenia Gravis.
- ב. myopathy ממקור בלוטת התריס.
- ג. שיתוק עצב Oculomotor.3
- ד. עין עצלה. (Amblyopia)

73. בן 13 שנים, סובל מאסטמה, מטופל במשאף (Foster 200/6 (Beclometasone/Formoterol) שתי שאיפות פעמיים ביום באופן קבוע מזה 4 חודשים אך ללא השגת שליטה במחלה .

מה השלב הבא בטיפול ?

- א. Prednisone פומי 15 מ"ג ליום באופן כרוני.
- ב. Azenil (Azithromycin) שלוש פעמים בשבוע.
- ג. Spiriva (Tiotropium)
- ד. העלאת מינון Formoterol.

74. בן 57, בריא בד"כ, BMI 32 עם אבחנה חדשה של יתר לחץ דם דרגה 2. איזו מההנחיות הבאות למניעת ל"ד, הנוגעות לשינוי אורחות חיים, מומלצות עבורו?
א. להגביל את צריכת הנתרן עד 3000 מ"ג נתרן ליום.
ב. להגביר את צריכת האשלגן לבין 3.5-4.7 גרם אשלגן ליום.
ג. להימנע מאלכוהול באופן מוחלט.
ד. הורדה של 4% מהמשקל ההתחלתי נחשבת לירידה משמעותית לצורך הפחתת לחץ הדם.
75. בן 70, ברקע - השמנת יתר וסוכרת, בעברו מספר אירועי צלוליטיס שהגיבו לטיפול אנטיביוטי פומי. כעת מתייצג עם כאב בשוק ימין מלווה בנפיחות ואדום. הוחל בטיפול אנטיביוטי Ceforal 1000 (Cephalexine) מ"ג 3 פעמים ביום. לאחר שבוע חוזר עם החמרה. שולל חום סיסטמי. בבדיקה: נפיחות בצקתית, אודם ורגישות בשוק. ללא שינוי באודם המקומי. איזו מהבדיקות הבאות הכי מתאימה בשלב זה בכדי להתקדם בבירור?
א. תרביית דם.
ב. צילום רנטגן של שוק ימין.
ג. דגימה עם מטוש עורי מהרגל לבירור עמידות.
ד. סונר דופלר ורידים עמוקים.
76. מהי ההמלצה לגבי הורדת חום בילדים?
א. בילד בריא, במצב כללי טוב, שחום גופו עד 38.5, אין צורך בהורדת החום.
ב. Paracetamol נמצא יעיל ובטוח יותר בהשוואה ל-Ibuprofen.
ג. אין לתת (Ibuprofen) Nurofen להורדת החום בילד עם אסטמה.
ד. להערכת חום ביילודים (Neonates) יש צורך במדידה רקטלית.
77. בת 75 מתלוננת על כאבים בכתפיים, עייפות, חום סובפיברילי וירידה במשקל מזה חודשיים. בבדיקה הגופנית: רגישות על מפרקי הכתפיים ובצקת גומתית בכפות הידיים, כח גס שמור דו"צ. שקיעת דם 80 מ"מ/שעה, CBC, TSH תקינים.
מה הפרוגנוזה של המחלה?
א. המחלה חולפת מעצמה תוך 1-2 חודשים.
ב. רוב החולים יפתחו וסקוליטיס תסמינית של כלי דם גדולים.
ג. Glenohumeral synovitis ב-US היא סמן פרוגנוסטי רע.
ד. רוב החולים יגיבו למינון נמוך של סטרואידים.

78. בת 72, לפני 4 חודשים מעדה בביתה ושברה את צוואר הירך מימין, נותחה ועברה שיקום. פונה לייעוץ עם התשובה הבאה של צפיפות עצם. מה מהבאים נכון עבור מטופלת זו ?

Densitometry: USA (Combined NHANES/Lunar)					
Region	BMD (g/cm ²)	YA (%)	YA T-score	AM (%)	AM Z-score
L1	1.134	100	0.0	118	1.4
L2	1.116	93	-0.7	108	0.7
L3	1.113	93	-0.7	108	0.7
L4	1.261	105	0.5	122	1.9
L1-L4	1.159	98	-0.2	114	1.2

Densitometry: USA (Combined NHANES/Lunar)					
Region	BMD (g/cm ²)	YA (%)	YA T-score	AM (%)	AM Z-score
Neck	0.795	77	-1.7	95	-0.3
Total	0.788	78	-1.7	91	-0.6

- א. צפיפות העצם שלה תקינה, אין צורך בהתערבות או טיפול .
- ב. Osteopenia מומלץ תוסף סידן וויטמין ד', פעילות גופנית בונה עצם .
- ג. Osteoporosis יש להתחיל טיפול בביספוספונט.
- ד. יש לחשב FRAX לצורך החלטה לגבי טיפול תרופתי .
79. בן 60, לפני שלושה ימים עבר אירוע קורונרי חריף, צונתר ושוחרר עם הטיפול התרופתי המתאים. נקבע לו תור להתחלת שיקום לב בעוד כחודשיים .
- מתי יכול לחזור לפעילות של יחסי מין עם בת הזוג שלו?
- א. יכול לקיים יחסים בעוד כ-4-5 שבועות .
- ב. להתחיל בהקדם כדי להימנע מדיכאון שלאחר אירוע לבבי.
- ג. יש לחכות לבדיקה ולהמלצות של מכון שיקום הלב.
- ד. מומלץ להמתין עד לביצוע אקו לב במאמץ.

80. בן 45, מכונאי רכב, מתלונן על רדימות באצבע 5 ומחצית מאצבע 4. בבדיקתו: ירידה בכוח האחיזה (grip).

איזו בדיקה הטובה ביותר לאבחון הבעיה ?

- א. MRI שורש כף היד.
- ב. CT עמוד שדרה צוארי.
- ג. מיפוי עצמות.
- ד. EMG לעצב האולנרי באזור המרפק.

81. בת 27, ברקע תסמונת המעי הרגיש (IBS) ללא טיפול תרופתי קבוע. וסתות סדירות. מקיימת יחסי מין עם פרטנר קבוע ומשתמשת באמצעי מניעה - קונדום. מתארת שנים של צריבה ואי נוחות בעת קיום יחסי מין וכן כאב בהחדרת טמפונים. שוללת תלונות אורינויות. בבדיקה גניקולוגית – מתואר אודם ורגישות באיזור (hymen שער הנרתיק) כמו כן רגישות במגע עם מטוש באיזור הוסיבולה האחורית. אין רגישות במגע עמוק עם שרירי רצפת האגן. בוצעו בדיקות דם וכן הושלמו תרבויות וגילניות וביופסיות וגילניות ללא ממצאים חריגים. שאר בדיקה גופנית תקינה.

מה הטיפול וההמלצות עבור האבחנה הסבירה ביותר?

- א. הימנעות ממוצרי היגיינה כגון שטיפות אינטימיות לא משפרת את התלונות.
- ב. טיפול מקומי בצמר גפן ספוג לידוקאין 2% המוכנס ל vagina-לפני שינה מקל על תסמינית.
- ג. אסטרופן מקומי לא חלק מהטיפול במצבה של המטופלת מכיוון שאינה פוסט מנופאוזלית.
- ד. טיפול בנוירומודולציה לצורך סטימולציה עצבית הינו חלק מאפשרויות הטיפול באבחנה הסבירה .

82. במי מהמקרים הבאים ניתן לאבחן אנאפילקסיס ?

- א. בן 3 חודשים, יונק בלבד, תפרחת אורטיקריאלית ללא מצוקה נשימתית.
- ב. בן שנה, לפני כשעתיים אכל במבה, פנה עקב סטרידור, במדידה ל.ד. נמוך לגילו .
- ג. בת 4, כשעה לאחר אכילת טחינה, בקוצר נשימה עם צפצופים בהאזנה לריאות, ל.ד. תקין .
- ד. בן 6, אלרגי למנגו, יום קודם אכל במסעדה, פנה עקב תפרחת אורטיקריאלית שהופיעה כעת .

83. בן 4 שנים מובא לבדיקה במרפאה לאחר שהגנת העירה להורים שההליכה שלו מוזרה. בבדיקה צולע בהליכה והולך על קצות בהונות רגל ימין. בנוסף הממצא הנ"ל.



מה מהבאים מהווה גורם סיכון לאבחנה המתאימה?

- א. מיעוט מי שפיר בהריון.
- ב. מחלה בדרכי נשימה עליונות.
- ג. השמנת יתר.
- ד. לידה בניתוח קיסרי.

84. בת 20 מלינה על הופעת בליטה בשורש כף היד (ראה תמונה), אותה מכירה מזה כשנה. לא סובלת מכאבים ולא מפריעה לה אסתטית .



איזה טיפול מהבאים מומלץ?

- א. לחץ עם חפץ כבד כדוגמת ספר.
- ב. (Aspiration) שאיבה במחט.
- ג. אספירציה והזרקת סטרואידים .
- ד. אין צורך בטיפול.

85. ליה בת 33, כלכלנית במקצועה, כעת בחופשת לידה. לפני 5 חודשים ילדה את בנה הבכור, מבקשת הפנייה לבדיקות דם בגלל עייפות. בעלה גויס למילואים, חוזר כל סוף שבוע הביתה. אימה נמצאת אתה ומסייעת בטיפול בילד אך היחסים עם האם אינם טובים, מרבה כהרגלה למתוח ביקורת על ליה. ליה אינה משתפת את בן זוגה בקשייה, לא רוצה להכביד עליו. מספרת שכשמגיע בסוף שבוע ממשיך לנהוג כרגיל, לא קם בלילה כשהילד מתעורר, נפגש עם חברים. איפה ניתן למקם את המשפחה על ציר הלכידות ועל ציר ההסתגלות לפי מודל Olson?

- א. לכידות נפרדת (Separated) והסתגלות מובנת. (Structured)
- ב. לכידות מחוברת (Connected) והסתגלות גמישה. (Flexible)
- ג. לכידות מנותקת (Disengaged) והסתגלות כאוטית. (Chaotic)
- ד. לכידות מעורבת יתר (Enmeshed) והסתגלות נוקשה. (Rigid)

86. בת 64 מתלוננת על סחרחורת סיבובית שהחלה כשקמה מהמיטה בבוקר, מלווה בבחילה, ללא הקאות.

- מה בבדיקה הגופנית מבדיל בין פגיעה מרכזית לפגיעה פריפרית?
- א. הופעת ניד (nystagmus) בהנעת הראש רומזת למקור פריפרי.
 - ב. Skew testing חיובי רומז לפתולוגיה מרכזית.
 - ג. מבחן Dix-Hallpike שלילי שולל Benign Paroxysmal Positional Vertigo.
 - ד. הופעת סקאדות (saccade) בבדיקת Head Impulse Test רומזת למקור מרכזי.

87. מהי ההמלצה למניעת תחלואה בשעלת (Pertussis) במדינת ישראל?

- א. מתן 6 מנות חיסון לכל ילד בישראל עד הגעתו לגיל 18.
- ב. חיסון כל האנשים במגע קרוב עם חולה שעלת.
- ג. מתן חיסון נגד שעלת לכל הנשים בהריון בטרימסטר הראשון.
- ד. חיסון מטפלות בגני ילדים ומעונות לתינוקות בתחילת העבודה.

88. בן 71 מספר שמהבוקר הוא הבחין בצל שמסתיר חלק משדה הראיה שלו בעין ימין. בנוסף מציין הופעה של כתמים צפים בעין זו.

אילו מהבאים סביר שהיוו גורמי סיכון למצב זה?

- א. עישון.
- ב. קוצר ראייה. (Myopia)
- ג. מיגרנה עם אאורה.
- ד. שימוש בסטרואידים מקומיים.

89. בן 38 שם לב למלאות במפשעה מימין. המלאות ניכרת בעיקר לאחר פעילות גופנית ממושכת ומוקלת בשכיבה. ללא עצירות או הקאות, ללא כאבי בטן.

בבדיקה: מסה רכה ולא רגישה בחלק המדיאלי של התעלה המפשעתית, אשכים תקינים. ללא לימפאדנופתיה בתחנות הרלוונטיות.

מהו המהלך המתאים ביותר?

א. יש לבצע אולטרסאונד לאישור האבחנה.

ב. מעקב סביל אפשרי במידה ואין כאבים או הגבלה בפעילות .

ג. ניתוח אלקטיבי בשל הסיכון המוגבר לסיבוכים לעומת מעקב בלבד.

ד. לאחר טיפול ניתוחי הסיכון להישנות הוא 25%.

90. בת 19 בריאה בד"כ, BMI תקין, מחזור סדיר, וסת אחרונה לפני 10 ימים. פנתה 4 ימים אחרי קיום יחסי מין לא מוגנים. לא מעוניינת להרות .

בהנחה שבדיקת הריון שלילית כעת, מהי ההמלצה המתאימה ביותר למטופלת זו כעת?

א. לתת לה היום גלולה מסוג Ella (Ulipristal) ולהתחיל גלולה משולבת אחרי 5 ימים.

ב. לתת לה היום גלולה מסוג Postinor (Levonorgestrel) ובמקביל להתחיל גלולה משולבת .

ג. סיכון מינימלי להריון בשלב זה של מחזור. תחילת גלולה משולבת היום למניעת הריון עתידי.

ד. הכנסת התקן מצופה פרוגסטרון כבר היום ובדיקת הריון חוזרת עוד שבועיים .

91. נערה בת 12 מלינה על פצעים בפנים ללא מעורבות איזורים אחרים .



הומלץ על טיפול מקומי משולב מסוג. Epiduo (Adapalene 0.1%, Benzoyl Peroxide 2.5%)

מה ההסבר למטופלת לגבי השימוש בתרופה זו?

א. השימוש מוגבל ל-12 שבועות עקב חשש להתפתחות של עמידות חיידקים לטיפול.

ב. להימנע מחשיפה לשמש (או להשתמש בקרם הגנה) במשך הטיפול.

ג. בתחילת הטיפול יש לשלב טיפול אנטיביוטי מקומי למשך שבועיים .

ד. במידה ואין שיפור לאחר 4 שבועות, מומלץ לעבור לטיפול פומי.

92. בת 32, ברקע 2 אירועים של PID שטופלו אנטיביוטית. מקיימת יחסי מין לא מוגנים עם בן זוגה

במטרה להרות מזה 3 חודשים ללא הצלחה.

מתי מומלץ להתחיל בירור אי פוריות במקרה זה?

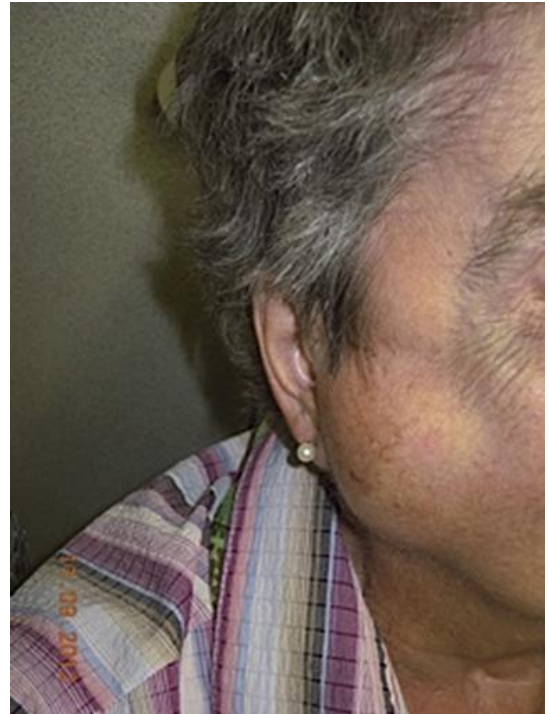
א. להתחיל בבירור מיד.

ב. אין צורך בבירור.

ג. בעוד 6 חודשים.

ד. בעוד 12 חודשים.

93. בת 82, כשבוע לאחר ניתוח בטן, מלינה על נפיחות בפנים, כאבים וקושי באכילה. בבדיקתה - חום 37.8 מ.צ., נפיחות באיזור TMJ לחי מימין (מצורפת תמונה), רגישות במישוש, בבדיקת הפה חשד ליציאת מוגלה מפתח בלוטת הרוק מימין.



מהו הטיפול המומלץ במצב זה?

- א. NSAIDS קומפרסים קרים והימנעות מעישון.
- ב. אנטיביוטיקה, סוכריות חמוצות ללא סוכר, קומפרסים חמים והידרציה.
- ג. קומפרסים חמים, וניקוז המוגלה ע"י רופא שיניים.
- ד. אנטיביוטיקה בלבד עם כיסוי לפלורה של חלל הפה.

שאלות על דרך השלילה

94. בת 55, מגיעה למרפאה מוטרדת לאחר שאביה אובחן עם דמנציה. היא בריאה ברקע, לא מעשנת. שואלת כיצד תוכל למנוע הופעת המחלה אצלה.

אילו מהממצאים הבאים לא הוכח כיעיל בהפחתת היארעות של דמנציה?

א. דיאטת Atkins.

ב. שתייה מתונה של אלכוהול.

ג. לשחק פינג-פונג.

ד. ללמוד שפה חדשה.

95. מבין הבאים איזה ממצא לא מעלה את החשד לשבר בברך באופן המצריך ביצוע צילום על פי קריטריוני OTTAWA?

א. רגישות בסדק המפרקי המדיאלי. (medial joint line tenderness)

ב. הגבלה בכיפוף הברך מעל 90 מעלות.

ג. רגישות מעל הפיקה (patella) או ראש הפיבולה. (head of fibula)

ד. חוסר יכולת לשאת משקל מעל 4 צעדים.

96. בן 50, מתגורר בהוסטל. ברקע - סרטן ריאה, סוכרת, עישון. מגיע למרפאה בליווי של עובר אורח שמצא אותו שוכב ברחוב. המלווה מתאר שהמטופל שכב בתוך שלולית שתן כשהוא רועד בכל גופו. המטופל מבולבל ואינו יודע להסביר מה קרה.

מה מבין האבחנות הבאות פחות סבירה שתסביר פרכוס ראשון במטופל זה?

א. גרורות מוחיות.

ב. היפוגליקמיה.

ג. תסמיני גמילה מאלכוהול.

ד. Psychogenic nonepileptic seizures (pseudoseizures)

97. כל הבאים נדרשים לצורך אבחון מחלות המתבטאות בקוצר נשימה, פרט ל-:

א. שיפור ב- FEV1 לאחר אינהלציה עם מרחיבי סמפונות מאבחן אסטמה .

ב. יחס של FEV1/FVC מתחת ל- 70 מאבחן COPD.

ג. לבדוק רמות IgE בסרום בחשד לאסטמה בילדים .

ד. לבדוק Alpha-1 AntiTrypsin בחולה COPD צעיר .

98. בת 31, נשואה ללא ילדים, בריאה, ללא טיפול תרופתי קבוע, אינה מעשנת, BMI 26. מזה שנתיים מנסה להרות. לאחר שתי הפלות בשבוע 11 ו-12.

מה **לא נכלל** בבירור לגבי סיבת ההפלות?

א. בדיקה לקרישיות יתר נרכשת (APLA) Anti Phospholipid Antibodies –

ב. בדיקת קרייטיפ.

ג. בדיקת המוגלובין, TSH, A1C ופרולקטין.

ד. בירור לזיהום תוך רחמי.

99. בת 40 מלינה על כאב ראש, שיבוש בווסת והפרשת נוזל לבן מהשדיים בחודשיים האחרונים. לידה אחרונה הייתה לפני 6 שנים.

מה **אינו** כלול בד"כ בבירור שלה?

א. בירור תרופות שנוטלת.

ב. בדיקת תפקודי תריס.

ג. CT/MRI מוח.

ד. מדדי דלקת: ESR, CRP.

100. מחקר RCT השווה בין מטופלים שקיבלו טיפול ב-SSRI Selective serotonin reuptake inhibitors) לבין מטופלים שקיבלו טיפול בפלצבו במשך כשנה.

מי **לא נכלל** בקבוצת ההתערבות על פי עקרונות ה-Intention-to-treat analysis?

א. משתתף שהוקצה לקבוצת הטיפול ב-SSRI והשלים את הטיפול והמעקב למשך שנה.

ב. משתתף שהוקצה לקבוצת הטיפול ב-SSRI אך פרש מהמחקר ומהמעקב לאחר חודשיים.

ג. משתתף שהוקצה לקבוצת הטיפול בפלצבו אך בפועל בחר להתחיל טיפול ב-SSRI.

ד. משתתף שהוקצה לקבוצת הטיפול ב-SSRI אך בפועל לא נטל את התרופה כלל.

בהצלחה